



עיצוב שירות סל אישי לגמלת הסיעוד סיכום סדנה

20 בנובמבר, 2024

משרד הרווחה והביטחון החברתי
מנהל אזרחים וותיקים
אגף תכנון מדיניות הזדקנות האוכלוסייה

איך נראה היום שלנו

התכנסנו ליום מלא עם נציגות בעלי עניין רלוונטיים לרפורמת "גמלת הסיעוד".

ישרנו קו על המצב הקיים, העמקנו, עבדנו בקבוצות ייעודיות, חלקנו ידע ומידע, מחשבות ורעיונות למודל השירות העתידי ובעיקר שאלנו עוד ועוד שאלות שצפו תוך כדי הסדנה.

הכרות ורקע 9:00-10:15

היכרות והצגת מטרות הסדנה
הצגת מחקר EY ומסע לקוח עתידי + מודל הגמלה הקיים וחדש
היכרות עם המתודה והתנהלות הסדנה

עבודה בקבוצות חלק א' 10:30-13:00

עבודה ב-3 קבוצות: (מה, איך, מי)

- היצע הסל הנדרש כמענה לצרכים (בסיס + מורחב)
- תהליכי עבודה תומכים בסל שירותים
- אפיון הפרסונות הדרושות לתהליך
- שיתוף והצגת תוצרי הקבוצות

עבודה בקבוצות חלק ב' 13:30-15:30

עבודה ב 2 קבוצות על סיכום ואינטגרציה:

- גיבוש עקרונות מנחים לפיילוט
- דיוק ופירוט מסע הלקוח החדש לאור התובנות
- שיתוף, דיון מסכם

סיכום והמשך צעדים 15:30-16:00



משתתפי הסדנה

ראש אגף תכנון מדיניות הזדקנות האוכלוסייה, מנהל אזרחים ותיקים, מוביל הסדנה ופורום ברק	משרד הרווחה, מוביל קבוצה	אביעד יצחקי
מנהל אזרחים ותיקים, מנהל אגף בכיר מערכי דיור מנהל אסטרטגיה	משרד הרווחה, מובילת קבוצה	חמה ישראלי שמייסר
אגף תכנון	משרד הרווחה	מיטל ויסמן
מנהלת השירות הסוציאלי, אגף הסיעוד	ביטוח לאומי, מובילת קבוצה	חיים פרג
מפקחת מחוזית	ביטוח לאומי	גלי גז
האינקובטור	מערך הדיגיטל הלאומי, מובילת קבוצה	מירב להב
האגף לשירותים חברתיים	עיריית נס ציונה, מובילת קבוצה	רותם לוי
מובילת הפיילוט לשעבר מנהלת קהילות תומכות בתגבור	עיריית ירושלים	ענת לזין
מוביל דאטה ומדידה באשל	הג'וינט	תמר ואר
מנהלת יזום- דאטה דיגיטל	הג'וינט, מובילת קבוצה	גלעד הדס
צוות יזום- דאטה דיגיטל	הג'וינט	דפנה לזין
מהלך הסיעוד אשל	הג'וינט	גלית אברהם
גריאטר ראשי	מכבי שירותי בריאות	דוד פלד
ראש מנהל אזרחים ותיקים	מאוחדת	זוריאן רדומיסלסקי
רכזת פיילוט סל מענים גמיש	עצמאית / עיריית תל אביב	ישי קום
מנכ"לית	Atvisor.ai	שני אבניאלי בכר
מנהלת חטיבת בריאות בארגון	MGROUP לשעבר סמנכ"ל לקוחות בלאומית	מורן רן
		שרית יופה

מנחות הסדנה

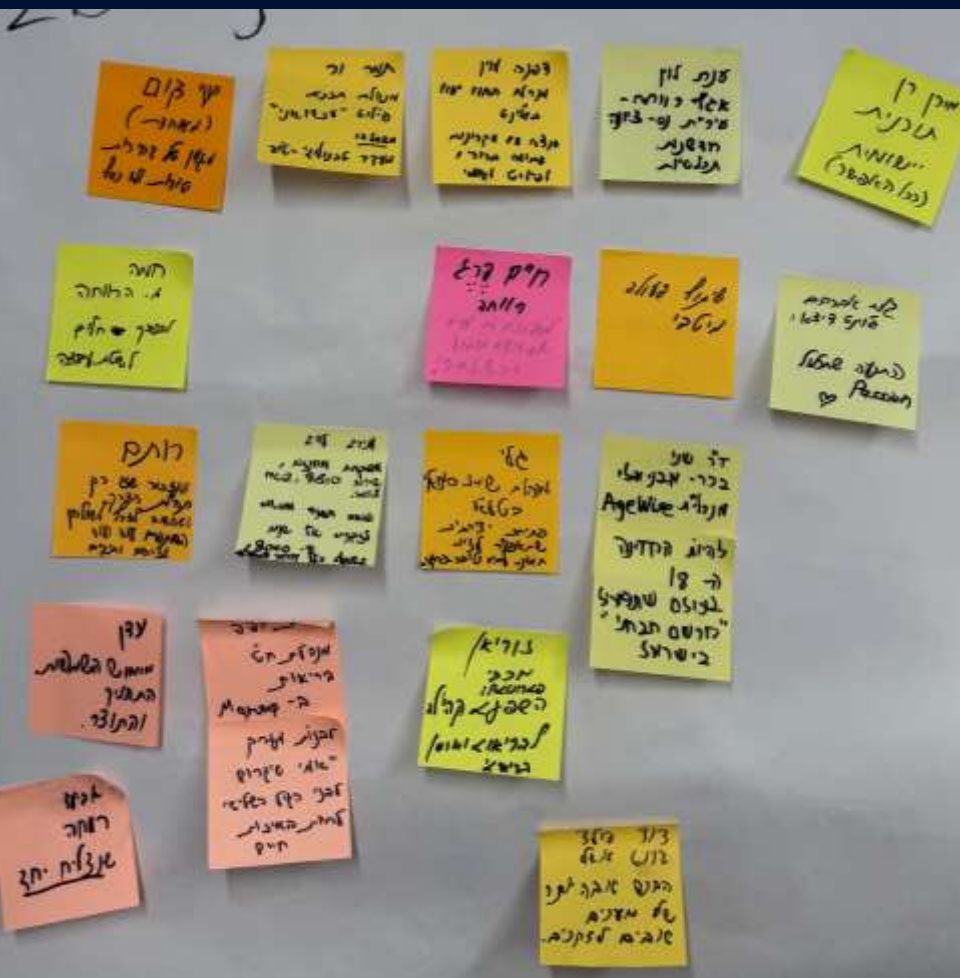
קרן שקד	B-Pro	מנחת יום הסדנה
עדנה לאופר	B-Pro	מנחת יום הסדנה



ציפיות מהסדנה

- יישומיות
- חדשנות
- שת"פ מיטבי – שותפות בין משרדית ומגזרית
- תוצרים לקידום הזדקנות מיטבית
- מחלום לשיטת עבודה
- תשוקה בעשייה

שהסדנה תהווה נדבך נוסף בתהליך פיתוח מודל חדשני לשירותי גמלת סיעוד בישראל





מטרת הסדנה

לעצב את מודל השירות החדש לגמלת הסיעוד, תוך התמקדות במניעת התדרדרות ודחיקת תלות, תמיכה בהזדקנות מיטבית ושיפור איכות החיים של מקבלי השירות.

להוות המשך ישיר למחקר שטח והמודל – לדייק, לתקף ולשפר את המנגנון המוצע ולפתח מודל יישומי.

תוצר בסוף הסדנה

עקרונות מנחים וגיבוש הפיילוט למסע הלקוח החדש כך שיסייע לאזרח הוותיק לבחור את השירותים המתאימים לו בצורה קלה ויעילה

הצגה של:

תקציר מחקר השטח של
חברת המחקר EY



מודל גמלת הסיעוד הנוכחית
מול החדשה





מטרת מודל השירות

יצירת סל שירותי הזדקנות מיטיבה שיסייעו במניעת התדרדרות ובחיזוק העצמאות,
התפקוד, ההשתתפות ותחושת השייכות של אזרחים ותיקים, שיסופקו באמצעות מנגנון
גמלת הסיעוד



אוכלוסיית היעד

הוגדרו שלוש קבוצות של מקבלי שירות –
כאשר השלב הראשון ביישום יתחיל מקבוצה א' (והיא גם הקבוצה שנבחנה במחקר השטח) ובהמשך ייבחנו הצורך וההתאמות הנדרשות ליישום המודל והתמריצים לשאר הקבוצות

קבוצה א'

זכאים **חדשים** לגמלת סיעוד בדרגה
1+2 או בודדים בדרגה 3

קבוצה ב'

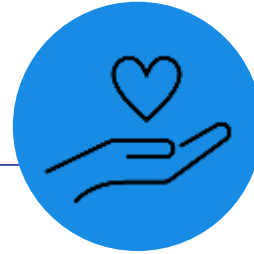
1. מקבלי גמלה קיימים בכל הדרגות
2. מקבלי גמלה חדשים בדרגות 3-6

קבוצה ג'

1. אזרחים ותיקים שאינם זכאים
לגמלת סיעוד עקב גובה
הכנסות וכו'
2. אזרחים ותיקים עצמאיים לצורך
מניעה

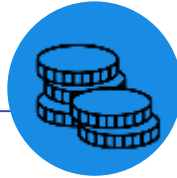
חשוב להדגיש כי אין במודל התייחסות או המלצות לשינוי במנגנוני ההכרה של הביטוח הלאומי ובתהליכי איתור ויישוג.
מומלץ בהמשך לקיים בדיקה בנוגע להתאמת מנגנוני ההכרה, האיתור והיישוג, כך כך שתיבחן האינטראקציה ביניהם לבין המודל המוצג.

הרכב גמלת הסיעוד במודל המוצע

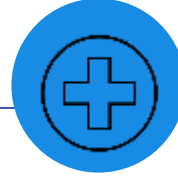


רכיבי גמלת הסיעוד

במודל החדש מוצה להרחיב את השירותים הניתנים במסגרת גמלת הסיעוד כדי לאפשר יותר בחירה למקבל הגמלה. אלו הרכיבים מהם יוכלו הזכאים לבנות את תמהיל הגמלה – כך שניתן יהיה לייצר תמהילים ושנים בין הרכיבים בהתאם לצרכיו של מקבל הגמלה



קצבה בכסף



שירותי סיעוד

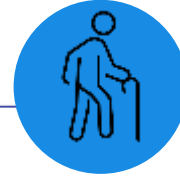
השירותים הקיימים כיום, כולל
שעות טיפול בבית, ולצידם
תוספת של שירותי ליווי/תמיכה
בניידות מחוץ לבית



שירותי הזדקנות מיטבית

ההמלצה לזכאים היא להמיר
לפחות 2 יחידות מהגמלה
לשירותי הזדקנות מיטבית –
כאשר נבחנת האפשרות לחייב
המרה של 2 יחידות מהגמלה

מודל השירות מתייחס לאופן
אספקת וצריכת שירותי הזדקנות
מיטבית בלבד



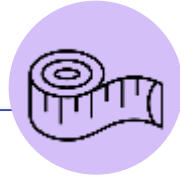
סל שירותי הזדקנות מיטבית

הסל מורכב משירותי הקהילה המקומית אליה משתייך מקבל השירות ועוד מבחר של שירותים בהתאמה אישית לצרכיו



שירותי מש"ח וקופ"ח

שירותים שמציעות המחלקה לשירותים חברתיים וקופ"ח באזור מגוריו של מקבל השירות המתאימים לצרכיו של מקבל השירות



שירותים מותאמים אישית

מגוון רחב של שירותים מותאמים לצרכי מקבל האדם כמו: חדר כושר, הרצאות בתחומי דעת שונים, עזרים טכנולוגיים, קורסי אוריינות דיגיטלית, טיולים מודרכים, טיפוח ועוד



שירותי קהילה מורחבים

שירותים נוספים שניתן לצרוך דרך הקהילה המקומית שמרחיבים את שירות הבסיס, מותאמים לצרכי הקהילה ולאזור בה היא פועלת



שירות קהילה מקומית

קהילה בת 150 חברים המתגוררים בסמיכות זה לזו אשר מנהלת על ידי מתאמת שירות ומספקת לחבריה שירותי בסיס דוגמת פעילויות חברתיות, מתאם שירות, ביקורי בית וכו'

גורמים מרכזיים במודל המוצע



ספק שירותי קהילה/מחלקה לשירותים חברתיים*

הגורם המתפעל את שירותי הקהילה, בסיסיים ומורחבים, באזור מסוים ופועל באמצעות:



מנהלת קהילות

מנהלת 10 קהילות מקומיות, מנחה ומדריכה את מתאמות השירות, מטפלת במקרים מורכבים, מסייעת בבניית התוכנית הקהילתית



מתאמת שירות

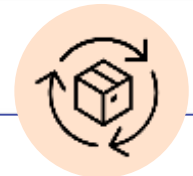
מרכזת את פעילות הקהילה המקומית שמונה כ-150 חברים, דואגת לצרכי החברים בקהילה, מקיימת ביקורי בית, מארגנת פעילויות ועוד

* תיתכן אפשרות שבחלק מהרשויות המקומיות שירותי הקהילה ובכלל זה מתאמת השירות ומנהלת הקהילות יסופקו באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים ולא באמצעות מפעיל חצוני



אזרחית ותיקה

זכאית לגמלת סיעוד בדרגות 1-2 וצורכת דרך הגמלה שירותי הזדקנות מיטבית



ספקי שירותים כלליים

מגוון רחב של ספקי שירות, ללא תלות בקהילה המקומית, אשר השירותים השונים שהם מציעים מרכיבים את השירותים המותאמים אישית. אלו יכולים להיות שירותים ייעודיים לאזרחים ותיקים או שירותים המסופקים לציבור הרחב שניתן יהיה לצרוך דרך גמלת הסיעוד



פלטפורמה דיגיטלית

הפלטפורמה הדיגיטלית מהווה בעצם סוג של "מרקטפלייס" אליו יכולה האזרחית הוותיקה להיכנס ולבחור שירותים מתוך סל שירותי הזדקנות מיטבית (מתוך שירותי הקהילה המורחבים, השירותים המותאמים שמציעים ספקי השירות הכלליים ושירות מש"ח וקופ"ח באזורה) בהתאם לצרכיה, כאשר השירותים המוצגים לה לבחירה הותאמו לצרכיה הייחודיים

שירות הקהילה המקומית - הרחבה



מנהלת קהילות

- כל 10 קהילות מנוהלות על ידי אשת מקצוע עו"ס/גרונטולוגית
- מנהלת הקהילות מכשירה, מדריכה ומלווה את מתאמות השירות בכל תפקידיהן
- היא גם מלווה באופן צמוד מקרים פרטניים מורכבים.



מתאמת השירות

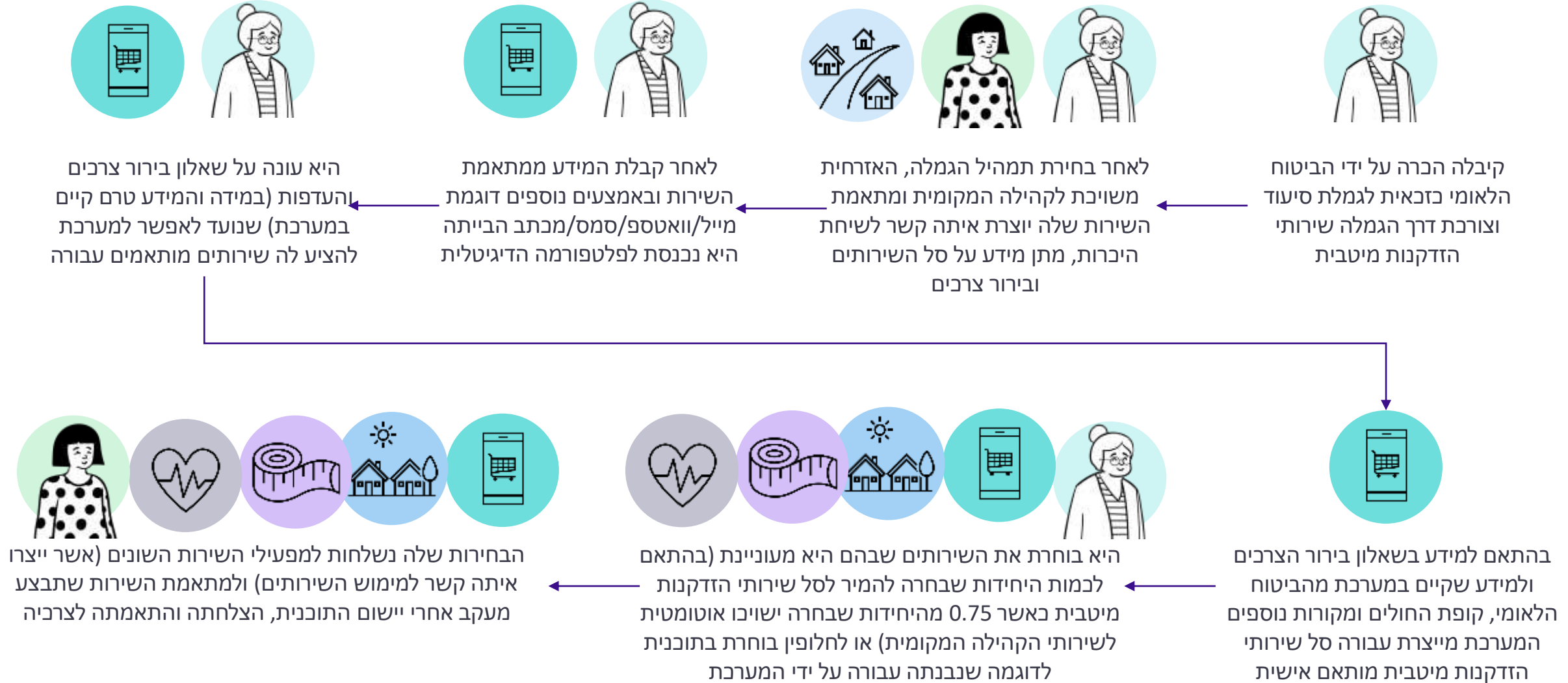
- מתאמת השירות מתכללת את עבודת הקהילה ונמצאת בקשר שוטף עם חברה
- היא בונה את תכנית הפעילות של הקהילה, כולל שירותי הקהילה המורחבים, ומעדכנת אותה אחת לחצי שנה על פי תוצאות המדידה והצרכים המשתנים של חברי הקהילה
- היא מסייעת למקבלי השירות לבחור את השירותים אשהם צורכים ואחת לחצי שנה מוודאת כי הסל מותאם לצרכי מקבל השירות



מאפייני הקהילה

- הקהילה פועלת באזור מגוריו של מקבל השירות והוא משויך אליה בהתאם למקום המגורים
- הקהילה יכולה להיות מופעלת על ידי ספק חיצוני או על ידי הרשות המקומית
- היא מורכבת מ-150 מקבלי שירות
- הקהילה מנוהלת על ידי מתאמת השירות

הליך בחירת השירותים



אופן אספקת השירותים – התקשרויות נדרשות

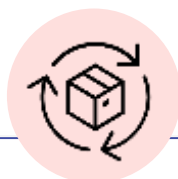
להפעלת שירותי ההזדקנות המיטבית נדרשים שלושה סוגי ספקים אשר ההתקשרות איתם תתבצע באמצעות מכרזים או קולות קוראים של הביטוח הלאומי



ספק לניהול הפלטפורמה

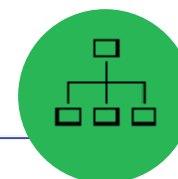
הדיגיטלית

מספקים שירותים לצריכה ישירה של מקבל השירות ללא תלות בקהילה אליה הוא שייך



ספקי שירותים כלליים

מספקים שירותים לצריכה ישירה של מקבל השירות ללא תלות בקהילה אליה הוא שייך



מפעילי שירותי קהילה

מספקים את שירותי הקהילה המקומית (בסיסיים ומורחבים) באזור מוגדר
קיימת אפשרות לרשות מקומית לחבור לספק לגשת יחד למכרז וכך לייצר מצב שכלל הקהילות ברשות מנוהלות במרוכז

למרות שמדובר בשלושה ספקים ומגוון שירותים, בפועל הספק לניהול הפלטפורמה הוא ספק תפעולי וכלל הספקים, הן של שירותי הקהילה והן של השירותים הכלליים, מספקים כולם סוגים שונים של שירותי הזדקנות מיטבית

אופן אספקת השירותים – הכנסת השירותים ללוח ח'2

- בכדי לספק את שירותי ההזדקנות המיטבית דרך גמלת הסיעוד נדרש להכניסם ללוח ח'2.
- המטרה היא לא להכניס כל שירות ושירות בנפרד מאחר וזה מטיל נטל רגולטורי ובירוקרטי לא סביר ולא מאפשר גמישות וחדשנות בסוגי השירותים שיכללו בסל ההזדקנות המיטבית.
- קיימות שתי חלופות מרכזיות להכנסת השירותים ללוח ח'2:

01

הוספת שירות חדש ללוח שייקרא:
"שירותי הזדקנות מיטבית"

02

שימוש בשירות **"קהילה תומכת"**
שכבר קיים בלוח תוך הרחבתו
והתאמתו למודל השירות החדש



המסע לסל האישי AI



התחלקנו ל-3 קבוצות עבודה

התמקדנו ב:

מה? איך? ומי?



חלק א' / קב' 1 / "מה?"

מה היצע הסל הנדרש כמענה לצרכים (בסיס + מורחב)

המטרה:

יצירת קטלוג שירותים מלא ומקיף המותאם למצבים ותרחישים יומיומיים של אנשים מבוגרים, תוך התאמת השירותים לצרכים השונים.

הנחייה לפעילות:

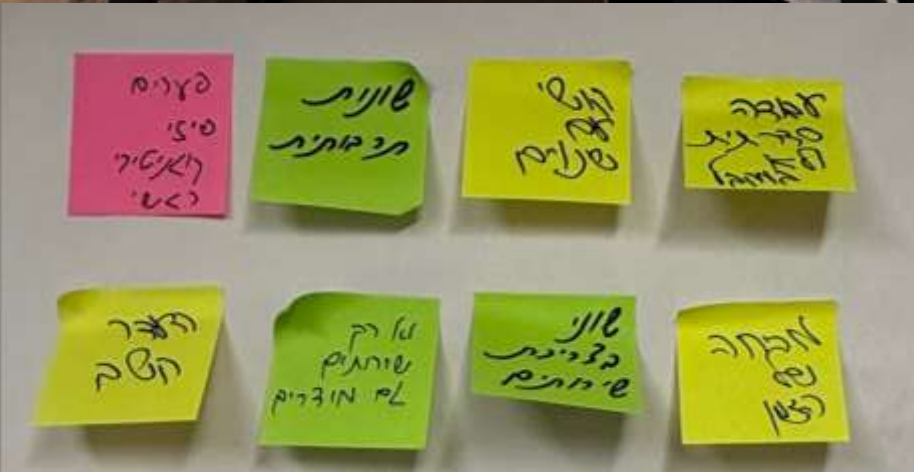
שלב 1 - זיהוי תרחישי חיים יומיומיים של אזרחים וותיקים
שלב 2 - התאמת שירותים לצרכים בתרחישים:

1. מה הסביבה בה הם מתרחשים (בבית, מחוץ לבית, אונליין)
2. זהו והציעו שירותים מתאימים להכניס לסל שיתמכו בצרכים השונים

- צרכים פיזיים
- צרכים חברתיים
- צרכים כלכליים
- צרכים קוגניטיביים
- צרכים דיגיטליים וטכנולוגיים



קב' 1 / "מה" - תובנות



5. **חשיבות ההתאמה האישית** – התייחסות למאפיינים שונים של התנהלות ביומיום המשפיעים על צריכת השירות דוגמת שינויים קוגניטיביים שמקשים לעבוד במקביל אלא סדרתית, מוסחות קשבית או אי שקט, קושי לקבל שינויים, שונות תרבותית בין קהלים ובאופן כללי היתכנות לפערים גדולים בין המשתמשים בכל ההיבטים התפקודיים – פיזי, קוגניטיבי, רגשי וחוש, אשר יובילו לשוני רב באופן צריכת השירותים.
6. **מניעת הצפה של שירותים** – אמנם רוצים לפתוח את השוק, לייצר מגוון אפשרויות, לתת חופש בחירה, אבל עדיין חשוב לא להגיע גם לקצה השני של כמות שירותים רבה מדי.
7. מעבר מבין הפתרונות שעלו למצבים השונים ניתן היה לראות **עירוב של שירותים ומוצרים** – האם משנה משהו במודל השירות?



חלק א' / קב' 2 / "איך?"

המטרה:

לזהות, לנתח ולבנות מפה ברורה של תהליך אספקת השירות לקשישים תוך התייחסות לכל הגורמים המעורבים, תחומי אחריותם, הממשקים ביניהם, ונקודות החיבור לשירותים השונים כדי ליצור מבנה תומך ואפקטיבי.

הנחייה לפעילות:

- שלב 1- זיהוי גורמים מעורבים ומיפוי תחומי אחריות
- שלב 2- מיפוי ממשקים ונקודות חפיפה בין הגורמים
- שלב 3- תיאור התהליך מנקודת מבט של כל גורם
- שלב 4 - זיהוי חיבורים נוספים עם שירותים משלימים

- הבנו שיש רמה לאומית עם **ועדת סל** חוצת משרדים שמגדירה את המדיניות והרגולציה של השירותים שנכנסים, והיא יושבת בתקשורת מול הרשות. מהווה:
 - גוף **תפעולי** שעושה בקרה על המפעילים
 - ועדה **מקצועית**
- **ועדת שירותים וספקים** – קביעת SLA, דרישות שירות, מדדי בקרה ופיקוח.
- ברשות המקומית / ברמה האזורית – **ועדת היגוי מקומית לסל השירותים**.
- מיפינו והבנו שיש לא מעט **שחקנים** והגדרות תפקידים חדשות. צריך להבין את הממשקים בניהם. חשוב לדעת לעבוד עם בעלי תפקידים קיימים לצד חדשים.
- יש הרבה עבודת **דאטה** – הדאטה קיים וצריך לדעת לתרגם אותו נכון, לעשות בו שימוש נכון.

חלק א' / קב' 3 / "מי?"

אפיון הפרסונות הדרושות הנוגעות לתהליך

המטרה:

ליצור 2 פרסונות מפורטות של נותני השירותים, כך שייצגו את אנשי המקצוע המרכזיים בתהליך אספקת השירות לקשישים.
כל פרסונה תכלול תיאור מפורט של התפקיד, תחומי אחריות, היקף פעילות, הכשרה נדרשת ויכולות מפתח.

הנחייה לפעילות:

שלב 1 - בחירת סוגי התפקידים המרכזיים: נהלו דיון ובחרו 2 סוגי תפקידים עיקריים לדעתכם בתהליך אספקת השירות דוגמאות לתפקידים אפשריים:
מתאמת שירות/ספק. ית שירותים/מנהל. ת קהילה/מנהל. ת מדור אזרחים ותיקים ברשות המקומית

שלב 2 - מילוי טמפלט תיאור דרישות התפקיד מהזווית של המעסיק לכל אחד מהתפקידים שבחרתם, הציגו בצורה מפורטת את הפרסונה על פי פרמטרים קבועים שמגדירים את תפקידו, אחריותו, מיומנותיו והכשרתו.



קב' 3 / "מי" - תובנות

מלווה חברתית:

- בונה עם התושב עצמו את הליווי השנתי
- חותרת להעצמת התושב
- מבצעת ליווי טלפוני ומעקב
- מוקד של מוטיבציה חיצונית – שמטרתו לבסוף להניע לפעולה ולשינוי

רכזת ליווי (עו"ס או גרונטולוגית) : שאלות שעלו בקבוצה:

- האם באחריות המלווה או הרכזת לבצע את האינטייק הראשוני?
- מהי מידת ההיכרות שלה עם המלווים? האם מכירה אותם דרך המלווה החברתית?

[illegible]

קבוצה #3 / ח"בגית פרסונות של נותני השירותים

חלק ב' / סיכום ואינטגרציה

קב' #1 - מסע לקוח חדש

קב' #2 - עקרונות מנחים לפיילוט



קב' 1 / מסע לקוח

המטרה: להבין את נקודות החוזק והחולשה במסע הלקוח, ולוודא שכל הממשקים והמעברים בתהליך ברורים, נגישים, ומסייעים לאזרח הוותיק לבחור את השירותים המתאימים לו בצורה קלה ויעילה. המסע מפרט את הפעולות שמבצעת הפרסונה, הרגשות הנלוות לכך והזדמנויות העולות מהם.

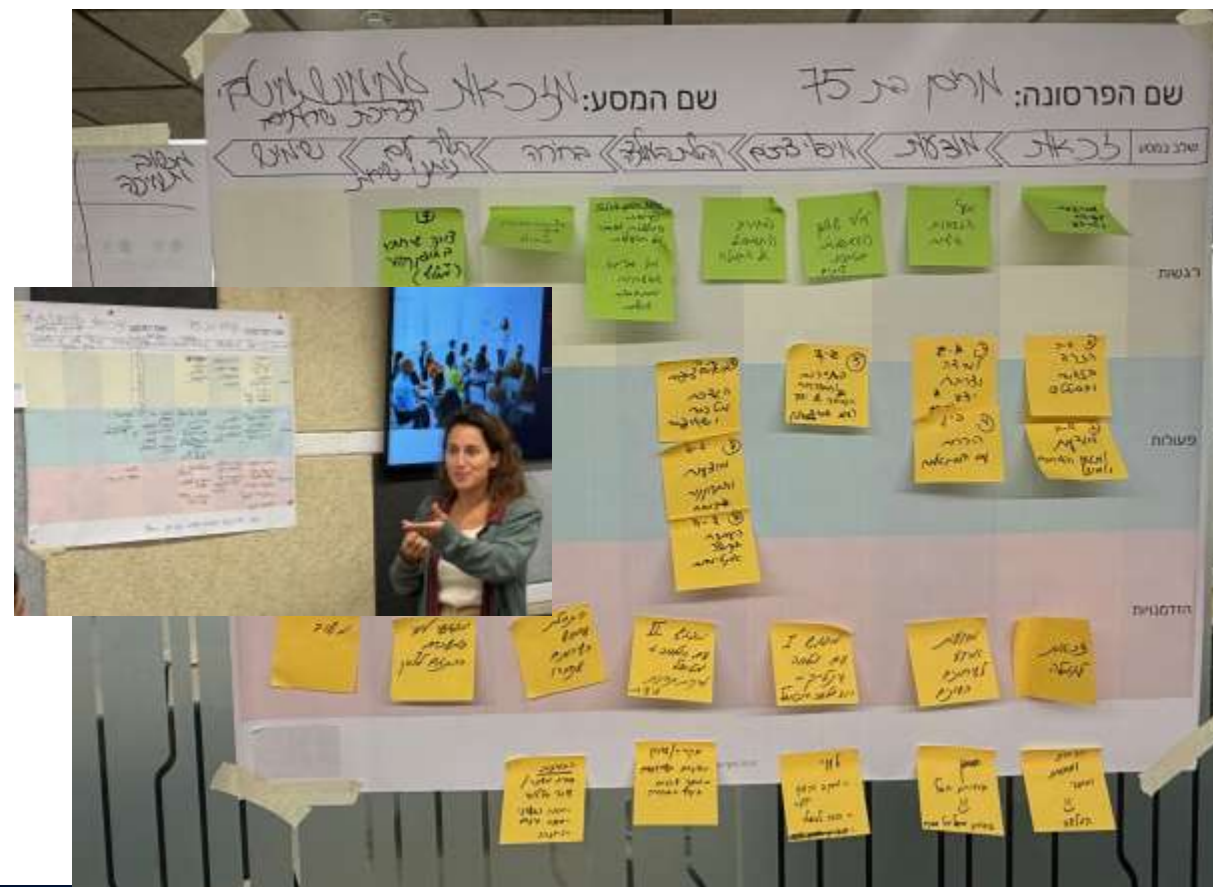
בשלב הראשון ניהלנו דיון על שלבי המסע. **השלבים שנבחרו הם:**

זכאות > מודעות > מיפוי צרכים > קבלת המלצה > בחירת תמהיל הגמלה > בחירת שירותים > קשר עם נותני שירות > שימוש > משוב ותמיכה

שם המסע: מזכאות לצריכת שירותים מיטבית – מסע להזדקנות מיטבית

שאלות שעלו:

- באופן עקרוני דיברנו על זה שיש "חורים בגבינה" בתוך המסע ויש לאפיין אותו בצורה יותר מעמיקה.
- ניהלנו דיון על מיקום שלב "בחירת תמהיל הגמילה", הוא חייב להיעשות על בסיס ידע והבנה, אחרי שהאדם ניסה את השירותים או למד עליהם. חשוב לדייק מהי הנקודה בזמן שבה האדם עושה שינוי בתמהיל הגמילה.
- עלה שיח לגבי מסע לקוח עם שירות אנושי וגם עם פלטפורמה דיגיטלית – כיצד נותנים לאדם לבחור באיזה אופן הוא יצרוך את השירות, איך בונים מסע לקוח משולב ומודולרי.



קב' 2 / עקרונות לפיילוט

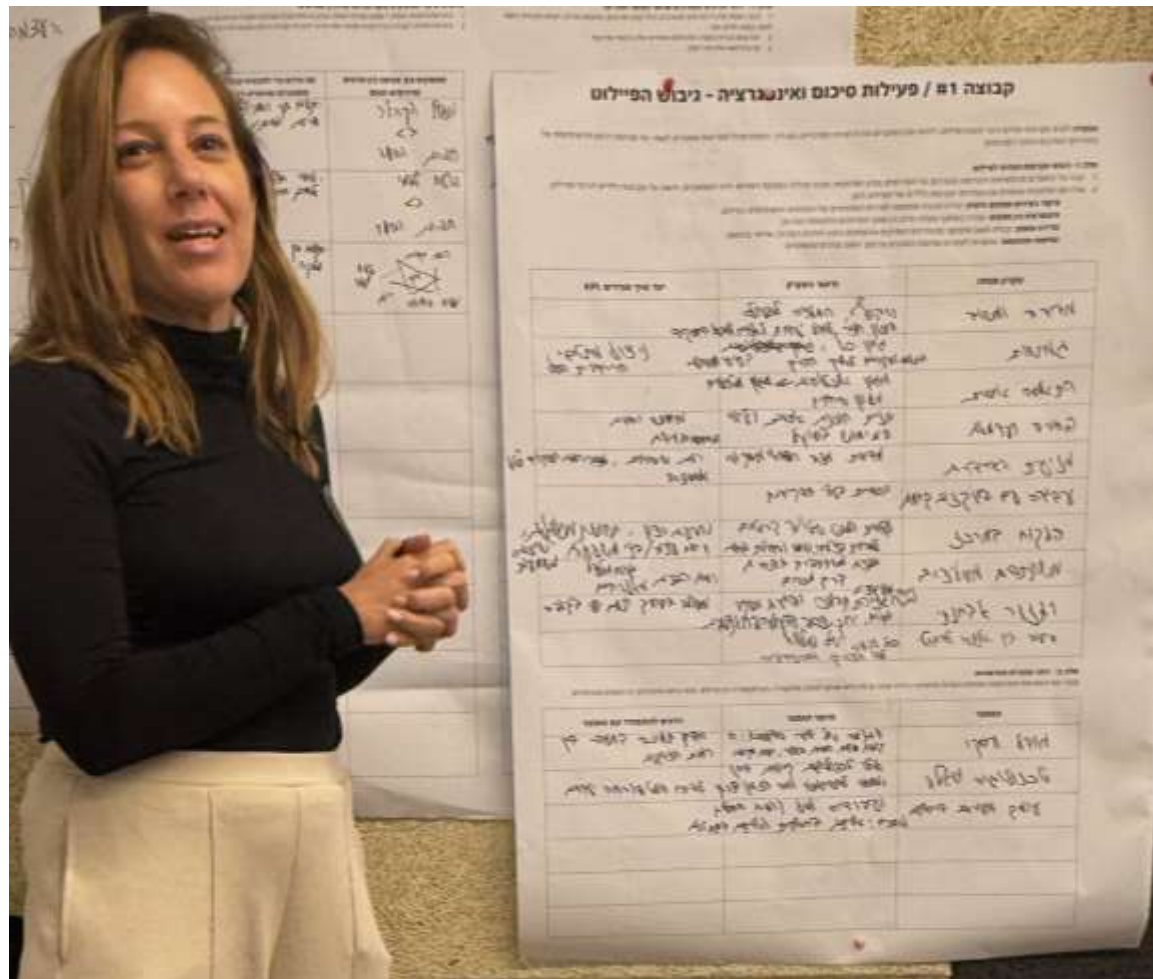
המטרה: לגבש עקרונות מנחים כיצד יבוצע הפיילוט, לזהות את האתגרים וההזדמנויות המרכזיים בתהליך, ולפתח מודל תמריצים שמטרתו לשפר את שביעות הרצון וההשתתפות של האזרחים הוותיקים וספקי השירותים.

עקרונות שהגדרתם: כל עקרון בפיילוט פרטנו לתתי- עיקרון.

בתוך הפיילוט אנחנו צריכים בסופו של דבר MVP ובו 4-5 עקרונות מנחים דוגמת: מדידה ומשוב, בחירה והתאמה אישית, גמישות ומגוון, בחירה ועצמאות של הזקן, מניעת הידרדרות, עבודה עם פונקציות קיימות, רמזור אבחנתי, שילוב בין אנושי לדיגיטלי, משתתפים ממליצים.

אתגרים:

- **תמריצים ותקציבים** - למי יש אינטרס למנוע את ההידרדרות? האם לקופת חולים, האם לחברות הסיעוד, האם למדינה? איך זה משפיע על המודל?
- **טכנולוגיה ודאטה** – פיתוח מערכת תומכת ומאפשרת לפיילוטים במקביל לאפיון מערכת לסקיילינג. איך רותמים אנשי מקצוע לרכיבי דיגיטציה?
- **המלווה החברתית** – תהליכי הכשרה, כלי סיוע ותמיכה, מיקודים, פרופיל, מי מפעיל ואיזה ממשקים נדרש.
- **מדידה בפיילוט** - צריך להבין שאיפה שיש אוכלוסייה הומוגנית יש הטיה. כדאי לקחת מדדים. נושאי מדידה, תמריצים וטכנולוגיה מטופלים בצוותים ייעודיים (נפרדים).
- **תמרוץ וגאווה** יחידה כמנופי שינוי, מעבר ממודל טיפולי למודל מניעתי קהילתי, תפקיד הקהילה במניעת התדרדרות.





דיון מסכם משוב, והמשך צעדים

צריך יותר לדייק את השינוי ולא לרוץ	המודל יכול להיות בשורה עולמית, מרשם חברתי חכם ורב מערכתי עם סל אישי AI	רשויות מקומיות הן "ה!" שחקן פה	חשיבה מעמיקה על רגולציה
יצאתי עם המון שאלות חשובות וברורות	העיקר ששמנו רגל בדלת	לרדת לשטח ולבדוק מראש אם אנשים באמת רוצים את זה ויבחרו בתמהיל החדש	פורום בר"ק מייצר תהליכים ששווה להיצמד אליהם
התהליך מבלבל, טוב שיש פיילוטים	ללמוד ממהלכים מוצלחים ופחות שנערכו במערך השיקום בבריאות הנפש	ללמוד מפיילוטים קיימים ולהתאים ולהטמיע להמשך	זה שלא יצאנו עם שום דבר קונקרטי - זה מעולה. התהליך היה טוב. אני שמח שהיה לנו את הלמידה על מה שקורה עכשיו בשטח.
אני יכול לקחת את העקרונות וליישם אותם במקומות אחרים	יש כוכב צפון עם כיוון ורצון משותף. ומצד שני - הדרך להגשים חזון - היא "לשבור" אותו. נשמור את מה שנכון ונדייק	המקום שבו אנחנו נמצאים יש חובה מטורפת לשנות את המערכת	

מילות הסיכום שלכם:

מילות הסיכום שלנו

קרן: הכנו סדנה מאוד ייחודית.
ידענו שאנחנו פותחות פה פתח
לדברים שיעלו ויש לתת להם
תשובות בהמשך.

עדנה: מהרגע הראשון - כל מי
שנגע לפיילוט בשטח נדבק
בחידק בהתרגשות. העובדה שיש
פיילוטים עובדים היא נקודת מוצא
מעולה ללמוד ממנה ולדייק.

התהליך האיטרטיבי הזה שבו
תהיו מאוד קשובים לשטח - מה
עבד טוב, מה עבד פחות טוב, מה
אנחנו לומדים מזה - זה מה
שיוביל בסוף. חשוב שתייצרו את
השגרה הזו.

אחד הדברים הכי קשים בקצמ
זה שמנסים להשיג כמה שיותר
ואז תפסת מרובה לא תפסת. אם
נגיד נבדוק בקצמ רק עשרה
חוגים ולא מאה - אלה החלטות
חשובות כדי להבין מה אתם
מודדים בכל פיילוט

חלק א' קבוצה 1 - "מה": היצע הסל הנדרש

[illegible][illegible][illegible]

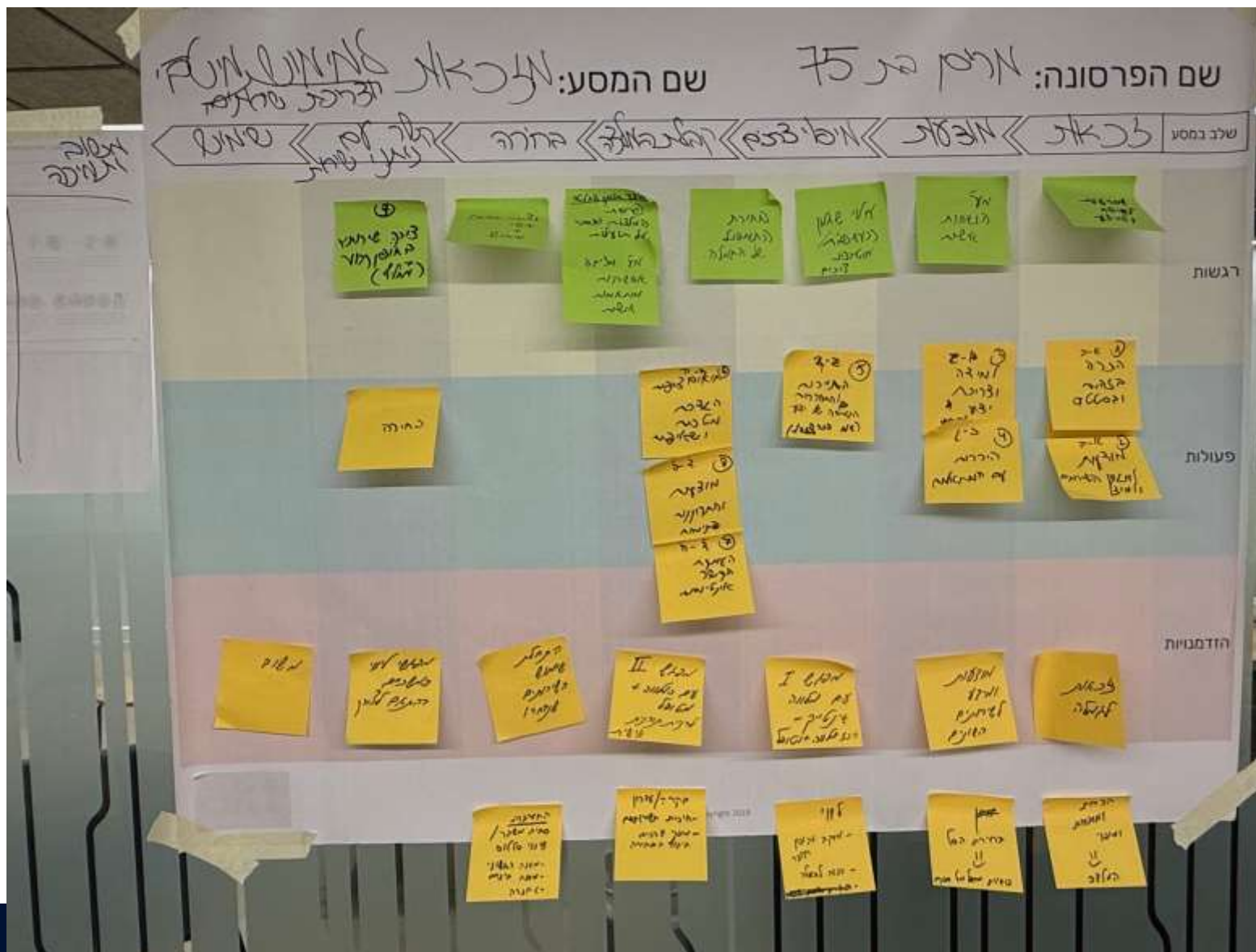
חלק א' קבוצה 2 – "איך": תהליכי עבודה

[illegible][illegible]

חלק א' קבוצה 3 - "מי": אפיון פרסונות ותפקידים

קבוצה #3 / מי: בניית פרסונות של נותני השירותים

[illegible]



חלק ב'
קבוצה 2: מסע לקוח

קבוצה #1 / פעילות סיכום ואינטגרציה - גיבוש הפיילוט

המחיר הנמוך ביותר של המוצר הוא 1.5 שקלים, והמחיר הגבוה ביותר הוא 2.5 שקלים. המחיר הנמוך ביותר של המוצר הוא 1.5 שקלים, והמחיר הגבוה ביותר הוא 2.5 שקלים.

שליש 1: ראשית עקבותיהם ב-1948

- מבית המדרש החדש, תל אביב-יפו

היקף נשיות סמוך ארץ, ירושלים, מדינת ישראל, 1997

המנהלים בן ספקים. אלוהים נשפך חילוה ודקוה בן ספקי סודותם וסודותם ודקוה

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

[illegible]

1997-1998 - 25th Anniversary

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

חלק ב'

קבוצה 1: גיבוש הפיילוט